

FASE50

EL MEJOR MOMENTO NO LO DECIDE LA EDAD.

GUÍA
40-70 AÑOS

DOSSIER DE SUPLEMENTACIÓN · MERCADO ESPAÑOL

Siete suplementos a examen

Qué merece la pena, qué depende del contexto y qué no compraría por inercia.

Evidencia, seguridad y decisiones de compra sin promesas milagro.

CRITERIO

Evidencia humana > mecanismo

ENFOQUE

Adultos 40-70 años

REVISIÓN

Septiembre 2026

00 · ANTES DE COMPRAR

No hay una pila universal de suplementos.

La pregunta útil no es "¿qué suplemento es bueno?", sino "**¿en qué contexto aporta algo que no estoy resolviendo ya con comida, entrenamiento, sueño o atención sanitaria?**"

Qué ha cambiado en esta revisión

Hemos actualizado la guía con evidencia disponible hasta septiembre de 2026 y hemos afinado varias afirmaciones. En particular: la vitamina D se presenta reconociendo su papel en hueso, músculo e inmunidad y la controversia real sobre qué nivel sanguíneo debe considerarse suficiente; el magnesio no se presenta como tratamiento habitual del insomnio; y la evidencia actual no respalda suspender omega-3 de forma automática antes de una cirugía. [4, 7, 8, 14, 15]

REGLA 1

Primero, el problema

Si no hay una necesidad concreta, el suplemento empieza con una desventaja: coste, adherencia y riesgo de interacción.

REGLA 2

Después, la etiqueta

Importa el principio activo, la dosis real por toma y el control de calidad. El tamaño del bote y el marketing vienen después.

Importante. Esta guía es divulgativa y no sustituye una valoración médica individual. Si tomas medicación, tienes enfermedad renal, hepática o cardiovascular, estás embarazada o tienes una cirugía programada, revisa cualquier suplemento con un profesional sanitario.

Las dosis que aparecen son rangos utilizados en estudios o referencias generales, no una prescripción individual. En personas sanas, una dieta variada, actividad física y un estilo de vida saludable siguen siendo la base.

01 · VEREDICTO

Mi prioridad práctica, no una receta.

La posición combina **solidez de evidencia, utilidad real y coste de oportunidad**. Que algo esté arriba no significa que todo el mundo deba tomarlo.

01	Creatina monohidrato La mejor combinación de evidencia, simplicidad y coste cuando hay entrenamiento de fuerza.	EVIDENCIA ALTA	€
02	Proteína en polvo Herramienta logística si la dieta no cubre la proteína necesaria. No es superior a la comida.	EVIDENCIA ALTA	€€
03	Vitamina D3 (+ K2) Relevante para hueso, músculo e inmunidad. El umbral óptimo sigue debatido y la necesidad de medir o suplementar depende del contexto.	CONDICIONAL	€
04	Omega-3 (EPA + DHA) Tiene sentido si el pescado azul es escaso o existe una indicación concreta. La dosis alta cambia el perfil de riesgo.	MEDIA-ALTA	€€
05	Magnesio Puede cubrir una ingesta baja; para sueño, la evidencia sigue siendo inconsistente y de baja certeza.	MEDIA	€
06	Colágeno Señales positivas en algunos resultados, pero la calidad y la financiación de los estudios obligan a moderar expectativas.	MEDIA-BAJA	€€
07	Electrolitos Útiles en calor, sudoración prolongada o pérdidas digestivas; innecesarios como hábito diario para la mayoría.	SITUACIONAL	€

Cómo leer el coste: € = bajo; €€ = medio; €€€ = alto. No incluimos precios fijos porque cambian con formatos, promociones y marcas. Compara siempre el coste por dosis efectiva, no por bote.

02 · FICHA RÁPIDA

Todo en una pantalla.

Suplemento	Rango / criterio	Qué buscar	Señal de alerta
Creatina	3-5 g/día. La carga es opcional.	Monohidrato simple; lote y pureza identificables.	Enfermedad renal conocida o analíticas que requieran interpretación clínica.
Proteína	20-40 g por toma si hace falta completar la dieta. En mayores sanos, ESPEN sitúa el mínimo habitual en 1,0-1,2 g/kg/día de proteína total.	% de proteína claro, pocos ingredientes, control de calidad.	Enfermedad renal avanzada o indicación dietética específica.
Vitamina D3	No hay dosis universal. Corregir niveles bajos puede ser relevante, pero las guías actuales no establecen un objetivo sanguíneo único ni recomiendan cribado rutinario en todo adulto sano.	Colecalciferol; evitar megadosis y bolos sin indicación.	Hipercalcemia, sarcoidosis, enfermedad renal, tratamientos específicos.
Omega-3	Priorizar pescado. Si suplementas, mira EPA+DHA reales. Evitar dosis altas por cuenta propia.	EPA+DHA por dosis, trazabilidad y control de oxidación.	Arritmias, anticoagulación, dosis >1,5 g/día en alto riesgo CV sin supervisión.
Magnesio	Priorizar alimentos. Si suplementas, controla el magnesio elemental y el límite europeo de 250 mg/día para sales suplementarias fácilmente dissociables.	Magnesio elemental declarado; forma tolerable para ti.	Función renal reducida; interacción con algunos fármacos.
Colágeno	Prueba limitada en el tiempo si tienes un objetivo concreto y medible.	Péptido/composición identificada y dosis transparente.	Promesas cosméticas o articulares desproporcionadas.
Electrolitos	Situacionales: ejercicio prolongado/calor, sudoración abundante o rehidratación indicada.	Sodio real por porción; composición simple.	Hipertensión, insuficiencia cardíaca/renal o fármacos que alteran potasio.

Referencias principales: [1, 3, 4, 6, 8, 10, 12].

03 · 01

Creatina monohidrato

La opción más fácil de justificar si entrenas fuerza y buscas preservar o mejorar rendimiento y masa muscular con la edad.

Lo que sí sabemos

- La evidencia en adultos mayores respalda mejoras en fuerza, composición corporal y función física, especialmente cuando se combina con entrenamiento de resistencia. [1]
- La creatina monohidrato es la forma con mejor respaldo; las variantes más caras no han demostrado una ventaja consistente.
- La investigación cognitiva es prometedora, pero todavía limitada: una revisión de 2026 encontró señales favorables, con pocos ensayos clínicos de alta calidad. [2]

Lo que conviene no vender

- No sustituye al entrenamiento. Sin estímulo de fuerza, gran parte de su utilidad práctica se reduce.
- Puede aumentar algo el peso al inicio por mayor agua intracelular; no equivale a ganar grasa.
- "Más" no es mejor. La constancia diaria importa más que perseguir dosis altas.

Si tuviera que elegir un solo suplemento para una persona sana que ya entrena fuerza, este sería el primero que valoraría.

Rango habitual

3-5 g/día. No es necesario hacer fase de carga.

Momento

Después de entrenar; en días de descanso, con una comida. Todos los días.

Forma

Monohidrato simple. La micronización puede mejorar la disolución.

Compra

Etiqueta corta, lote identificable, pureza y fabricante trazables.

Precaución: si existe enfermedad renal diagnosticada o una situación clínica que afecte a la interpretación de creatinina, consulta antes y avisa de que tomas creatina cuando te hagan analíticas.

03 · 02

Proteína en polvo

No es un atajo metabólico. Es una forma cómoda de llegar a una cantidad de proteína que, con la edad y el entrenamiento, puede ser más difícil cubrir solo con las comidas.

La cifra que importa es la del día entero

ESPEN sitúa para personas mayores sanas un mínimo habitual de **1,0-1,2 g/kg/día**, ajustable según actividad, estado nutricional, enfermedad y tolerancia. En enfermedad o riesgo de desnutrición pueden necesitarse cantidades mayores bajo supervisión. [3]

Cuándo gana puntos

- Desayunos y comidas con poca proteína.
- Entrenamiento de fuerza con dificultad para alcanzar el objetivo diario.
- Pérdida de peso donde interesa preservar masa magra.
- Falta de tiempo o apetito para una comida completa.

Qué mirar en la etiqueta

- Gramos reales de proteína por 100 g y por ración.
- Lista de ingredientes corta y comprensible.
- Si hay intolerancia a la lactosa, un aislado puede ser más cómodo.
- En mezclas vegetales, combinación de fuentes puede mejorar el perfil de aminoácidos.

Antes de comprar un bote, registra un día real de comidas. A veces el problema no es "qué proteína", sino que el desayuno aporta muy poca.

Toma habitual

20-40 g de proteína, según el resto de la comida y tus necesidades.

Mejor momento

Cuando resuelve un hueco. El total diario pesa más que la hora exacta.

Prioridad

Comida primero; polvo cuando aporta comodidad o adherencia.

No confundir

Más proteína no sustituye al entrenamiento ni corrige una dieta pobre.

Precaución: en enfermedad renal avanzada u otras situaciones clínicas, la cantidad total de proteína debe individualizarse con el equipo sanitario.

03 · 03

Vitamina D3 (+ K2)

La vitamina D participa en la salud ósea, la función muscular y el sistema inmunitario. La discusión actual no es si importa, sino **a quién conviene medir, qué nivel perseguir y cuándo suplementar**. [14]

Un umbral que sigue en debate

No existe hoy un único punto de corte aceptado por todas las sociedades. El IOM/NASEM ha considerado que alrededor de **20 ng/ml** cubre las necesidades de la mayoría de la población sana, mientras que consensos españoles y sociedades del ámbito óseo han utilizado históricamente **valores por encima de 30 ng/ml**. La propia SEEN reconoce esta controversia. [15]

¿Por qué importa también para la inmunidad?

- La vitamina D es necesaria para el funcionamiento normal del sistema inmunitario. [14]
- Los niveles bajos se asocian con mayor riesgo de algunas infecciones respiratorias, aunque suplementar no ha mostrado un beneficio uniforme en todos los ensayos.
- Corregir un nivel bajo y suplementar a una persona ya suficiente no son la misma intervención.

¿Por qué muchas guías no criban de rutina?

Pese a su relevancia fisiológica y a la elevada prevalencia de niveles bajos descrita en España, la evaluación de vitamina D no forma parte del cribado rutinario del adulto sano en muchas guías actuales. **¿Por qué?** Porque no se ha demostrado que medir sistemáticamente a adultos asintomáticos mejore resultados clínicos y no existe un umbral universal de 25(OH)D asociado de forma consistente a todos los beneficios extraóseos. [4]

No confundir «no cribado rutinario» con «la vitamina D no importa». Esa recomendación se refiere a población generalmente sana; una valoración individual puede estar justificada cuando existen factores de riesgo, síntomas o indicaciones clínicas.

Si está indicada

En mayores de 50 años se prefieren pautas diarias y moderadas frente a bolos grandes. [4]

Vitamina K2

No es obligatoria para que la D «funcione» y puede interferir con antagonistas de vitamina K como acenocumarol o warfarina. [11]

Seguridad: hipercalcemia, sarcoidosis, enfermedad renal y determinados tratamientos requieren valoración clínica. El límite superior tolerable de 4.000 UI/día no es una dosis objetivo. [10]

03 · 04

Omega-3 (EPA + DHA)

El error clásico es leer "1.000 mg de aceite de pescado" y pensar que son 1.000 mg de EPA+DHA. **No es lo mismo.**

Qué sí tiene sentido

- Priorizar pescado azul si encaja en tu alimentación.
- Si suplementas, comparar **EPA + DHA reales** por dosis, no el peso total del aceite.
- Las dosis terapéuticas para triglicéridos pertenecen al ámbito médico, no a la automedicación con suplementos.
- La calidad y la oxidación importan más que un reclamo de "ultra concentrado".

El punto de seguridad

- Un metaanálisis de 2025 encontró aumento de fibrilación auricular en personas de alto riesgo cardiovascular tratadas con dosis >1.500 mg/día de EPA/DHA. [6]
- En cambio, un metaanálisis de 2024 no encontró aumento global de sangrado con omega-3; la señal fue pequeña con EPA purificado a dosis altas. [7]

Etiqueta

Busca EPA y DHA por cápsula/ración, no solo "aceite de pescado".

Momento

Con comida suele mejorar tolerancia gastrointestinal.

Calidad

Trazabilidad, antioxidantes, control de oxidación y certificación independiente suman puntos.

Cirugía

Informa al equipo quirúrgico de todos los suplementos. No suspendas nada por tu cuenta basándote solo en esta guía.

Precaución: si tienes arritmia, fibrilación auricular, alto riesgo cardiovascular o tratamiento anticoagulante/antiagregante, revisa dosis y necesidad con un profesional.

03 · 05

Magnesio

Tiene funciones fisiológicas reales y una ingesta dietética que a veces se queda corta. Eso no lo convierte automáticamente en un tratamiento para dormir mejor.

Sueño: evidencia más modesta de lo que vende el marketing

Una revisión sistemática de 2026 concluyó que los ensayos de magnesio para sueño muestran resultados inconsistentes y una certeza de evidencia baja o muy baja. No respalda su uso rutinario como tratamiento del insomnio. [8]

Primero, comida

- Legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales y verduras verdes aportan magnesio.
- El objetivo no es "tomar magnesio", sino cubrir necesidades.
- Si suplementas, revisa el **magnesio elemental**, no los miligramos totales de la sal.

Si decides probarlo

- El citrato puede ser más laxante.
- El bisglicinato suele ser bien tolerado, aunque no tiene una superioridad universal demostrada para todos los objetivos.
- La respuesta individual y la tolerancia importan.

Límite europeo

250 mg/día de magnesio procedente de sales suplementarias fácilmente dissociables en adultos, según EFSA/SCF. [10]

Interacciones

Puede interferir con algunos antibióticos y bisfosfonatos; también conviene separar de levotiroxina según indicación farmacéutica.

Precaución: la función renal reducida aumenta el riesgo de acumulación. En ese contexto, no suplementes por rutina.

03 · 06

Colágeno

No es humo puro, pero tampoco la certeza que sugiere buena parte de la publicidad. La palabra clave aquí es **incertidumbre**.

Lo que juega a favor

- Existen ensayos y revisiones con señales favorables en piel, articulaciones y algunos resultados musculoesqueléticos.
- Algunos péptidos específicos se han estudiado con dosis y objetivos concretos.
- Puede tener sentido como prueba limitada si el objetivo es medible y el coste no desplaza intervenciones más importantes.

Lo que obliga a frenar

- Un metaanálisis de 2025 observó que los estudios no financiados por la industria y los de mayor calidad no mostraban beneficio significativo en hidratación, elasticidad o arrugas. [9]
- Otras revisiones encuentran resultados favorables, de modo que la literatura no es completamente uniforme.
- Es una proteína incompleta y no debe sustituir proteína de calidad en la dieta.

Si lo pruebas, hazlo como un experimento: un objetivo concreto, una duración definida y una medida antes/después. Si no cambia nada, no conviertas la inercia en suscripción mensual.

Compra

Evita fórmulas que oculten la dosis. Mejor composición y péptido identificables.

Expectativa

Los cambios, si aparecen, suelen ser modestos; no esperes un efecto cosmético o articular inmediato.

Prioridad

Antes: proteína suficiente, entrenamiento, sueño y una dieta completa.

Vitamina C

Una dieta normal suele cubrirla; no hace falta perseguir megadosis para "activar" el colágeno.

03 · 07

Electrolitos

Son útiles cuando hay una pérdida real de agua y sales. **No necesitan convertirse en una bebida diaria de oficina.**

Cuándo sí

- Ejercicio prolongado con calor y sudoración abundante.
- Trabajo físico intenso en ambientes calurosos.
- Pérdidas digestivas: aquí el referente es el **suero de rehidratación oral** de farmacia, no una bebida deportiva.
- Situaciones clínicas concretas indicadas por un profesional.

Cuándo no por rutina

- Una sesión corta en clima templado.
- Pasar el día sentado y beber "electrolitos" porque suena saludable.
- Usar dosis altas de sodio o potasio sin saber qué aporta ya la dieta o qué medicación tomas.

Una aparente paradoja: sal en la dieta y suero salino en urgencias

Si se recomienda moderar la sal, ¿por qué el suero salino es tan habitual en el hospital? El **cloruro sódico al 0,9 %** contiene **9 g de NaCl por litro**, con 154 mmol/L de sodio y 154 mmol/L de cloruro. Se utiliza cuando existe una necesidad clínica de reponer volumen o sodio, corregir determinadas pérdidas o como vehículo para medicamentos; no porque una ingesta alta de sal sea saludable. [16, 17]

La reflexión útil es otra: **el sodio es esencial, pero la dosis y el contexto mandan**. La recomendación dietética diaria y una perfusión intravenosa responden a situaciones completamente distintas. Los fluidos IV también pueden causar sobrecarga, hipercloremia o alteraciones ácido-base si se usan sin necesidad o en exceso. [17]

Etiqueta

Mira los miligramos de sodio por ración. "Con electrolitos" no dice cuánto.

Potasio

No suplementes a ciegas si tomas fármacos que elevan potasio o tienes enfermedad renal.

Hidratación

La necesidad depende de duración, temperatura, sudoración y tolerancia individual.

Gastroenteritis

Usa soluciones de rehidratación oral formuladas para ese fin.

Precaución: hipertensión mal controlada, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y determinados antihipertensivos cambian por completo la decisión.

04 · RUTINA

El mejor horario es el que puedes mantener.

En la mayoría de estos productos, la constancia y el contexto pesan más que perseguir una ventana de diez minutos.

DESAYUNO

Proteína, si el desayuno se queda corto. **Vitamina D**, solo si la tienes indicada; con una comida que contenga grasa suele ser práctico.

DESPUÉS DE ENTRENAR

Creatina diaria. En días de descanso, tómalala con una comida.

ANTES / DURANTE ENTRENAMIENTO

Electrolitos solo si duración, calor y sudoración lo justifican. **Colágeno**, si lo estás probando para un objetivo musculoesquelético específico, sigue el protocolo del producto/estudio que estés usando.

CON COMIDAS

Omega-3 suele tolerarse mejor con comida. Divide tomas si reduce el reflujo.

NOCHE

Magnesio, si lo usas y te resulta cómodo; no hay una hora mágica. Separa de medicamentos que puedan interactuar siguiendo indicación del farmacéutico/médico.

La regla FASE50

Si un suplemento exige una rutina tan compleja que te hace abandonar el entrenamiento, la comida o el descanso, está restando más de lo que suma.

No mezcles suplementos y medicación sin revisar interacciones. El riesgo real suele estar menos en "qué hora" y más en qué fármacos, enfermedades y dosis coinciden.

05 · PRESUPUESTO

Gastar mejor antes que gastar más.

Los precios cambian demasiado rápido para que una cifra fija siga siendo fiable. Por eso esta edición usa una jerarquía de gasto.

NIVEL 0

Antes del bote

Fuerza + proteína de alimentos + sueño + dieta completa.

Si esto falla, los suplementos no compensan el hueco.

NIVEL 1

Núcleo práctico

Creatina si entrenas fuerza.
Proteína en polvo solo si resuelve un déficit práctico.

La mayor parte del retorno suele estar aquí.

NIVEL 2

Según contexto

Vitamina D, omega-3, magnesio, colágeno y electrolitos entran **si existe una razón concreta**, no por completar una lista.

Cómo comparar dos botes

- Calcula el precio por dosis efectiva, no por cápsula.
- Descarta fórmulas que no indiquen la cantidad real del principio activo.
- Un sello de calidad puede sumar, pero no convierte una dosis inútil en útil.
- Desconfía de mezclas propietarias, promesas de "detox", "hormonal reset" o curación.

El suplemento más caro es el que compras durante seis meses sin saber qué problema estaba resolviendo.

06 · SEGURIDAD

Seis situaciones que cambian la decisión.

01

Anticoagulantes

Vitamina K puede interferir con warfarina, acenocumarol y fármacos similares. Mantén una ingesta estable y no añadas K2 sin supervisión. [11]

02

Función renal reducida

Magnesio, potasio y la estrategia de proteína requieren más cautela. La decisión depende del grado de función renal y del tratamiento.

03

Levotiroxina / bisfosfonatos

Minerales como magnesio o calcio pueden interferir con la absorción. La separación horaria debe seguir la ficha del medicamento o la indicación profesional.

04

Hipertensión / insuficiencia cardíaca

Los electrolitos ricos en sodio y los suplementos de potasio pueden ser inapropiados según medicación y función renal.

05

Arritmias / alto riesgo CV

Evita dosis altas de omega-3 por tu cuenta. En alto riesgo cardiovascular, dosis >1.500 mg/día de EPA+DHA se asociaron con más fibrilación auricular. [6]

06

Cirugía programada

Informa de todos los suplementos al equipo quirúrgico. La evidencia no justifica una regla universal de "suspender omega-3 7-10 días"; sigue las instrucciones de tu equipo. [7]

Regla simple: no inicies, suspendas ni sustituyas medicación por lo que leas aquí. Y si un suplemento produce síntomas nuevos, suspéndelo y consulta.

07 · MÁS IMPORTANTE QUE LA LISTA

Cuatro decisiones con más retorno.

FUERZA

Entrenar de forma progresiva

Dos o tres sesiones semanales bien diseñadas pueden aportar más a fuerza y función que añadir suplementos a un estilo de vida sedentario.

PROTEÍNA

Repartir mejor el día

Antes de comprar polvo, identifica qué comidas están claramente por debajo de lo que necesitas.

SUEÑO

Tratar el problema real

Si hay insomnio persistente, ronquidos intensos, pausas respiratorias o somnolencia diurna, un suplemento no sustituye una evaluación adecuada.

DATOS

Medir lo que sí cambia decisiones

Tensión arterial, peso/cintura, rendimiento y analíticas indicadas por tu profesional pueden orientar mucho mejor que comprar por intuición.

La idea central de esta guía

Los suplementos funcionan mejor como **herramientas pequeñas dentro de una estrategia grande**. Si se convierten en la estrategia, el orden se ha invertido.

YA ESTÁS DENTRO

Un correo a la semana con la letra pequeña.

Como has recibido esta guía a través de FASE50, no vamos a pedirte el email otra vez. Cada semana recibirás una pieza breve para separar lo útil de lo que solo suena bien.

FASE50 · El mejor momento no lo decide la edad.

08 · FUENTES

De dónde sale esta revisión.

- [1] Candow DG, et al. *Creatine monohydrate supplementation for older adults and clinical populations*. J Int Soc Sports Nutr. 2025. PMID: 40673730.
- [2] Marshall S, et al. *Creatine and Cognition in Aging: A Systematic Review of Evidence in Older Adults*. Nutr Rev. 2026;84(2):333-344. PMID: 40971619.
- [3] Volkert D, et al. *ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics*. Clinical Nutrition. 2022;41:958-989.
- [4] Demay MB, et al. *Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline*. J Clin Endocrinol Metab. 2024.
- [5] LeBoff MS, et al. *Supplemental Vitamin D and Incident Fractures in Midlife and Older Adults*. N Engl J Med. 2022;387:299-309.
- [6] *Effects of Omega-3 Fatty Acid Treatment on Risk for Atrial Fibrillation: An Updated Meta-Analysis of 34 Trials including 114,326 Individuals*. 2025. PMID: 41445624.
- [7] Javaid M, et al. *Bleeding Risk in Patients Receiving Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials*. J Am Heart Assoc. 2024;13:e032390. PMID: 38742535.
- [8] Lopresti AL, et al. *Magnesium Supplementation for Sleep in Adults: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials*. J Diet Suppl. 2026;23(5):553-581. PMID: 42661485.
- [9] Myung SK, Park Y. *Effects of Collagen Supplements on Skin Aging: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials*. Am J Med. 2025;138(9):1264-1277. PMID: 40324552.
- [10] EFSA. *Summary of Tolerable Upper Intake Levels*. Version 10, June 2024. Incluye UL de vitamina D y magnesio suplementario.
- [11] NIH Office of Dietary Supplements. *Vitamin K - Health Professional Fact Sheet*. Interacciones con warfarina, acenocumarol y anticoagulantes similares.
- [12] World Health Organization. *Sodium reduction*. Actualización 11 May 2026. Recomendación adulta: <2.000 mg/día de sodio (<5 g/día de sal).
- [13] Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods; AESAN guidance on nutrition and health claims.
- [14] NIH Office of Dietary Supplements. *Vitamina D - Datos en español y Suplementos dietéticos para la función inmunitaria*. Relevancia de la vitamina D para función inmunitaria y revisión de evidencia en infecciones respiratorias.
- [15] Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). *Recomendaciones de vitamina D*. Revisión de la controversia sobre puntos de corte de 25(OH)D y referencias españolas.
- [16] Sodium Chloride 0.9% Intravenous Infusion BP. *Summary of Product Characteristics*. Composición: 9 g/L de NaCl; Na+ 154 mmol/L; Cl- 154 mmol/L.
- [17] NICE. *Intravenous fluid therapy in adults in hospital (CG174)*. Indicaciones, prescripción, monitorización y riesgos de la fluidoterapia intravenosa.

Nota editorial y legal

Este documento es una revisión divulgativa. No diagnostica, previene, trata ni cura enfermedades y no sustituye una valoración médica individual que tenga en cuenta tu historia clínica, medicación y analíticas. FASE50 no comercializa los suplementos citados en esta guía y esta edición no contiene enlaces de afiliación ni patrocinio de marcas.

Las menciones a dosis, formas o usos describen rangos estudiados o criterios generales. No deben interpretarse como una pauta individual. La disponibilidad, composición y etiquetado de productos pueden cambiar; revisa siempre el envase actual y, si existe medicación crónica o enfermedad, consulta antes de iniciar un suplemento.

Revisión editorial: septiembre de 2026. Se priorizaron guías clínicas, revisiones sistemáticas, metaanálisis y organismos públicos. Cuando la evidencia es incierta o contradictoria, se indica expresamente.